Hồ sơ thực hiện tiêu chí D2.4

Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

Dự thảo trình duyệt năm 2026. Bộ hồ sơ cung cấp ma trận yêu cầu, quy định triển khai đề xuất, kế hoạch, chỉ số và biểu mẫu để các đơn vị bổ sung minh chứng thực tế. Chưa có căn cứ kết luận mức đạt của bệnh viện.

Số văn bản và phiên bản .....

Ngày phê duyệt và áp dụng .....

Người soạn thảo .....

Người rà soát .....

Người phê duyệt .....

Đầu mối và cách sử dụng

Bộ phận QLCL phối hợp Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Điều dưỡng, CNTT và toàn bộ đơn vị cung cấp dịch vụ. Đây là phân công đề xuất, phải xác nhận với cơ cấu và thẩm quyền thực tế trước ký.

Không ghi lùi ngày, tạo chữ ký hoặc điền số liệu thay cho hoạt động chưa thực hiện. Mã biểu mẫu là mã đề xuất, cần thống nhất với quản lý tài liệu bệnh viện. Hồ sơ tiêu chí quản lý không bị ép theo đề cương quy trình kỹ thuật QĐ3023.

1 Căn cứ và nguyên tắc đối chiếu

Căn cứ trực tiếp: QĐ6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016, Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, D2.4, trang in 125 [1]. Ma trận sau diễn giải rút gọn, giữ số mục và mức để tra cứu cùng bản gốc.

Bộ phận QLCL và pháp chế đối chiếu thêm hướng dẫn kiểm tra của kỳ đánh giá thực tế; không mặc định mọi viện dẫn trong phần căn cứ lịch sử năm 2016 còn hiện hành. Các nội dung quyền người bệnh thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 và văn bản liên quan hiện hành.

Kiểm tra tình trạng bất lợi mức 1 trước. Khi có tình trạng mức 1, xử lý và đánh giá theo hướng dẫn của Bộ tiêu chí; không biến tình trạng đó thành yêu cầu tích cực. Nếu không có tình trạng mức 1, đối chiếu tích lũy mức 2–5, không lấy trung bình số ô đáp ứng để xếp mức.

Quy tắc ít nhất hai thông tin định danh là biện pháp an toàn đề xuất dựa trên WHO [2], không gán thành nguyên văn một tiểu mục của QĐ6858. Không dùng số phòng hoặc số giường làm thông tin định danh.

Nhãn bệnh phẩm vẫn phải đáp ứng tối thiểu họ tên, năm sinh và giới theo tiểu mục 11, cùng mã người bệnh, mã mẫu và thông tin chuyên môn cần thiết theo quy định xét nghiệm. Một mã vạch không tự thay việc đối chiếu người bệnh và dịch vụ.

D2.4 là quy định an toàn chung; hồ sơ không thay quy trình truyền máu, dùng thuốc, phẫu thuật hoặc kỹ thuật cụ thể. Các quy trình kỹ thuật đó áp dụng QĐ3023 về đề cương và nguồn chuyên môn tương ứng.

2 Ma trận tiểu mục 1 đến 10

Mục mức	Nội dung đối chiếu	Minh chứng cần có
1 M1	Có nhầm người bệnh gây hậu quả nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần theo mô tả tiêu chí	Hồ sơ sự cố, xác minh và hậu quả.
2 M2	Có quy định xác nhận đúng người bệnh và dịch vụ trước thực hiện	Quy định được duyệt, áp dụng toàn viện.
3 M2	Có bảng nhắc các bước tại nơi dễ thấy	Bản nội dung và kiểm tra vị trí.
4 M2	Có quy định bàn giao đúng người bệnh giữa nhân viên	Hướng dẫn và biểu mẫu bàn giao.
5 M2	Phổ biến quy định cho nhân viên	Tài liệu, danh sách và kiểm tra hiểu biết.
6 M2	Có danh sách trường hợp cung cấp nhầm dịch vụ trong năm	Sổ sự cố và danh sách đã xác minh; nếu không có phải có căn cứ.
7 M3	Nhân viên thực hiện đủ bước xác định chính xác người bệnh	Quan sát và kiểm tra thực hành.
8 M3	Có bảng kiểm đối chiếu người bệnh và dịch vụ	Bảng kiểm phù hợp từng nhóm dịch vụ.
9 M3	Áp dụng đối chiếu tên, năm sinh, đặc điểm liên quan; xác nhận người nhà khi không thể trả lời	Ghi nhận thực hành, cách xử lý người không xác định.
10 M3	Đánh dấu bằng phương thức thủ công hoặc CNTT người bệnh, bệnh phẩm, thuốc, vật tư liên quan	Nhãn, vòng, hồ sơ và khả năng truy vết.

Kết quả từng dòng: ghi tại phiếu tự đánh giá cuối hồ sơ. Dẫn mã minh chứng và vị trí tra cứu; quan sát một thời điểm không thay thế yêu cầu theo dõi cả năm khi tiêu chí có quy định.

2 Ma trận tiểu mục 11 đến 18

Mục mức	Nội dung đối chiếu	Minh chứng cần có
11 M3	Nhãn bệnh phẩm có tối thiểu họ tên, năm sinh, giới	Mẫu nhãn và kiểm tra bệnh phẩm.
12 M4	Tất cả người bệnh có mã số hoặc mã vạch duy nhất	Quy tắc cấp mã, dữ liệu và kiểm tra trùng.
13 M4	Ứng dụng CNTT, thiết bị điện tử và mã để xác nhận tên và dịch vụ	Quan sát quy trình, nhật ký và xử lý lỗi.
14 M4	Không nhầm người bệnh trong xét nghiệm, CĐHA, thăm dò chức năng và phát thuốc	Đối chiếu nhiều nguồn sự cố, phản ánh và kiểm tra.
15 M5	Trong năm không nhầm khi cung cấp mọi dịch vụ	Dữ liệu toàn năm và xác minh, không chỉ sổ trống.
16 M5	Rà soát biện pháp phòng nhầm ít nhất một lần mỗi năm	Kế hoạch, hồ sơ kiểm tra, báo cáo.
17 M5	Báo cáo nêu yếu tố, hành vi, kỹ thuật có nguy cơ và giải pháp	Phân tích nguyên nhân và nguy cơ.
18 M5	Cải tiến theo kết quả đánh giá	Thực hiện, theo dõi và kiểm tra lại.

Kết quả từng dòng: ghi tại phiếu tự đánh giá cuối hồ sơ. Dẫn mã minh chứng và vị trí tra cứu; quan sát một thời điểm không thay thế yêu cầu theo dõi cả năm khi tiêu chí có quy định.

3 Quy định triển khai đề xuất

Mục tiêu: Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ. Phạm vi bao gồm các đơn vị liên quan trực tiếp và bộ phận hỗ trợ. Ban Giám đốc phê duyệt quy định, nguồn lực và phân cấp; trưởng đơn vị tổ chức thực hiện, giám sát và xử lý phát sinh; QLCL tổng hợp kết quả và theo dõi cải tiến.

Xác nhận chủ động ít nhất hai thông tin

Trước mỗi dịch vụ, đề nghị người bệnh tự nói họ tên và ngày sinh; đối chiếu với mã người bệnh, vòng/hồ sơ và chỉ định. Nếu chỉ biết năm sinh hoặc thông tin chưa đủ, dùng thông tin thứ hai đáng tin cậy theo quy định được duyệt, không tự bịa ngày sinh. Tránh hỏi dẫn “có phải anh A không”.

Đối chiếu đúng dịch vụ

Kiểm tra người bệnh, chỉ định, thuốc, mẫu, thủ thuật và vị trí hoặc bên liên quan. Với phẫu thuật, truyền máu và dịch vụ nguy cơ cao, thực hiện thêm bảng kiểm chuyên biệt và xác nhận độc lập theo quy trình; nhận diện đúng không thay kiểm tra an toàn khác.

Dán nhãn tại nơi thực hiện

Lấy mẫu đúng người, dán và kiểm tra nhãn ngay tại nơi lấy trước khi rời người bệnh; không dán sẵn cho nhiều người. Kiểm tra nhãn, phiếu chỉ định và mẫu khớp nhau; mẫu sai/thiếu thông tin xử lý theo quy định xét nghiệm, không tự sửa nhãn để hợp thức hóa.

4 Xử lý tình huống và kiểm soát thực hiện

Xử lý trường hợp đặc biệt

Người không thể trả lời: đối chiếu vòng/hồ sơ, người đại diện hoặc nguồn tin đáng tin cậy; ghi cách xác minh. Người chưa rõ danh tính: cấp mã tạm duy nhất theo quy định cấp cứu, đối chiếu nhất quán và hòa giải dữ liệu sau xác minh, không trì hoãn cấp cứu. Trẻ sơ sinh, đa thai: dùng định danh riêng từng trẻ và đối chiếu liên kết mẹ–con khi bàn giao.

Dừng khi không khớp và bàn giao an toàn

Nếu lệch thông tin, dừng dịch vụ chưa khẩn cấp, báo người phụ trách, kiểm tra nguồn và sửa theo thẩm quyền có dấu vết. Khi cấp cứu thực hiện quy trình nhận diện tạm song song cứu chữa. Khi chuyển khoa/ca, bên giao nhận cùng đối chiếu ít nhất hai định danh, tình trạng và dịch vụ; xử lý lỗi máy quét bằng quy trình dự phòng đã duyệt.

Ghi nhận và kiểm soát minh chứng

Ghi đúng thời điểm, người thực hiện, kết quả và việc chưa hoàn thành. Phân quyền truy cập, dùng mã thay dữ liệu định danh trong báo cáo tổng hợp; giữ hồ sơ chi tiết ở nơi được phép. Chứng cứ ảnh phải có bối cảnh, thời gian và mục đích phù hợp, không công khai thông tin người bệnh trái quy định.

Tài liệu và bảng nhắc cần được rà soát chuyên môn, phê duyệt đúng thẩm quyền, cấp phiên bản và phổ biến. Khi thay đổi phải thu hồi bản cũ và hướng dẫn lại. Đào tạo có nội dung, danh sách tham dự thật, kiểm tra khả năng thực hiện và kế hoạch học bù.

5 Kế hoạch triển khai và đo lường

T0 là ngày phê duyệt thực tế. Lịch dưới đây là đề xuất để đơn vị điều chỉnh theo nguồn lực; không phải lịch bắt buộc do Bộ tiêu chí ấn định.

Thời hạn	Công việc	Sản phẩm
T0 + 15 ngày	Khảo sát từng tiểu mục, xác định khoảng thiếu.	Dữ liệu nền và phân công.
T0 + 30 ngày	Trình quy định, công cụ, nguồn lực và đào tạo.	Văn bản được duyệt và hồ sơ phổ biến.
T0 + 60 ngày	Triển khai, kiểm tra thực hành, ghi dữ liệu.	Biểu mẫu thực tế và xử lý tồn tại.
T0 + 90 ngày	Đánh giá, phản hồi, cải tiến và đo lại.	Báo cáo và hành động theo dõi.

Tuân thủ xác định người bệnh

Số lượt dịch vụ quan sát có đủ bước định danh và đối chiếu dịch vụ / tổng lượt quan sát × 100%. Phân tầng thuốc, mẫu, CĐHA, thủ thuật và bàn giao; ghi rõ phương pháp chọn mẫu.

Mẫu bệnh phẩm đủ thông tin

Số mẫu kiểm tra có nhãn đúng, đủ và khớp người bệnh/chỉ định / tổng mẫu kiểm tra × 100%. Ghi riêng sai tên, thiếu năm sinh/giới, sai mã và nhãn không khớp.

Nhầm lẫn và sự cố suýt xảy ra

Báo riêng số sự cố thực sự đến người bệnh và số suýt xảy ra; phân loại hậu quả. Không có báo cáo không đồng nghĩa không có sự cố; đối chiếu phản ánh, trả mẫu, sửa hồ sơ và điều chỉnh đơn thuốc.

Trước đo phải khóa định nghĩa, kỳ, mẫu số và cách chọn đối tượng. Mẫu số bằng 0 ghi không tính được; thiếu dữ liệu ghi chưa xác minh. Không làm tròn dưới ngưỡng thành đạt hoặc suy rộng một mẫu nhỏ thành toàn bộ bệnh viện.

6 BM01 Bảng kiểm trước dịch vụ

Mã đề xuất D24 BM01.

Ngày giờ, đơn vị, nhân viên, dịch vụ và mã đợt .....

Người ghi và đơn vị .....

Thông tin cần đối chiếu	Nguồn xác nhận	Khớp hoặc không khớp	Xử lý và xác nhận

Bảng nhắc tại điểm chăm sóc: HỎI CHỦ ĐỘNG → ĐỐI CHIẾU ÍT NHẤT HAI ĐỊNH DANH → KIỂM TRA ĐÚNG DỊCH VỤ → CHỈ THỰC HIỆN KHI KHỚP. Không khớp: dừng dịch vụ chưa khẩn cấp và báo xử lý; cấp cứu theo quy trình định danh tạm.

Hai định danh thực tế: 1 ..... 2 .....
Nguồn và dịch vụ khớp: □ Có □ Không. Không dùng phòng/giường để định danh.

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

6 BM02 Bàn giao và trường hợp đặc biệt

Mã đề xuất D24 BM02.

Ngày giờ, bên giao nhận, mã chính thức hoặc mã tạm .....

Người ghi và đơn vị .....

Hai định danh và nguồn	Tình trạng và dịch vụ	Điểm chưa xác minh	Người xử lý, kết quả

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

6 BM03 Quan sát và giám sát định danh

Mã đề xuất D24 BM03.

Kỳ, vị trí, người quan sát và cách chọn lượt .....

Người ghi và đơn vị .....

Lượt và nhóm dịch vụ	Hai định danh và đúng dịch vụ	Nhãn hoặc quét mã	Sai lệch và xử lý

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

6 BM04 Sự cố và kế hoạch phòng nhầm

Mã đề xuất D24 BM04.

Mã sự cố, ngày phát hiện; hồ sơ chi tiết lưu phân quyền .....

Người ghi và đơn vị .....

Sự việc và hậu quả	Nguyên nhân hệ thống	Hành động, người và hạn	Đánh giá lại

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

7 Danh mục minh chứng và tự đánh giá

Nhóm	Hồ sơ cần tập hợp	Mã và vị trí
MC01	Quy định, quyết định phân công, nguồn lực và phê duyệt.	
MC02	Hồ sơ phổ biến, đào tạo, kiểm tra thực hành và học bù.	
MC03	Biểu mẫu đã thực hiện, dữ liệu nguồn, quan sát và phỏng vấn.	
MC04	Chỉ số, báo cáo, phản hồi, cải tiến và đo lại.	
MC05	Hồ sơ phản ánh, sự cố và xác minh tình trạng mức 1.	

Kỳ đánh giá và phạm vi .....

Tình trạng mức 1 và bằng chứng xác minh .....

Mức đề xuất sau kiểm tra tích lũy .....

Khoảng thiếu và người chịu trách nhiệm .....

Người lập và người kiểm tra .....

Có bộ hồ sơ không đồng nghĩa đạt tiêu chí. Phải kiểm tra hoạt động tại hiện trường và đối chiếu dữ liệu nguồn; các trường hợp chưa xác minh giữ nguyên trạng thái chưa xác minh.

Phụ lục tự đánh giá tiểu mục 1 đến 12

Kỳ và người kiểm tra .....

Mục	Thực trạng hoặc mức đáp ứng	Mã minh chứng	Việc cần bổ sung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Mục 1 ghi có/không tình trạng bất lợi. Các mục khác ghi đáp ứng/chưa đáp ứng/chưa xác minh. Trường hợp không áp dụng chỉ sử dụng khi hướng dẫn cho phép và có căn cứ. Người kiểm tra: .....

Phụ lục tự đánh giá tiểu mục 13 đến 18

Kỳ và người kiểm tra .....

Mục	Thực trạng hoặc mức đáp ứng	Mã minh chứng	Việc cần bổ sung
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Mục 1 ghi có/không tình trạng bất lợi. Các mục khác ghi đáp ứng/chưa đáp ứng/chưa xác minh. Trường hợp không áp dụng chỉ sử dụng khi hướng dẫn cho phép và có căn cứ. Người kiểm tra: .....

8 Nguồn và kiểm tra trước ban hành

[1] Bộ Y tế. QĐ6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016, tiêu chí D2.4, trang in 125.

https://trungtamytehuyentanyen.vn/public/uploads/files/quyet-djinh-6858qdj-byt-nam-2016-ve-bo-tieu-chi-chAt-luong-benh-vien-viet-nam-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh_5faed01464.pdf

[2] WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions. Patient Identification, May 2007. Khuyến nghị ít nhất hai định danh và không dùng số phòng.

https://www.who.int/docs/default-source/integrated-health-services-%28ihs%29/psf/patient-safety-solutions/ps-solution2-patient-identification.pdf

Ngày đối chiếu nguồn 16/10/2026. Bộ phận phụ trách xác nhận hướng dẫn kiểm tra áp dụng cho kỳ đánh giá thực tế; đối chiếu thêm TT35/2024/TT-BYT về tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với bệnh viện khi lập hồ sơ chất lượng chung.

□ Điền số văn bản, phiên bản, ngày áp dụng và người có thẩm quyền.

□ Chốt đầu mối, nguồn lực, lịch triển khai và mục tiêu từ thực trạng.

□ Rà soát nội dung, biểu mẫu và quy định chuyên môn, pháp lý liên quan.

□ Phê duyệt, phổ biến và kiểm tra việc áp dụng.

□ Bổ sung dữ liệu và minh chứng thật trước khi ký kết luận mức đạt.